



Collection MedWIZ

5^e année médecine

SANTÉ MENTALE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Cours :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Urgences psychiatriques	8				
02	Trouble obsessionnel-compulsif (TOC)	12				
03	Troubles dépressifs	14				
04	Schizophrénies	16				
05	Troubles à symptomatologie somatique	18				
06	Trouble délirant (Délire paranoïaque)	20				
07	Troubles veille-sommeil	22				
08	Trouble de stress post-traumatique (TSPT) et troubles liés au stress	24				
09	Trouble bipolaire	26				
10	Troubles anxieux	30				
11	Aspects médico-légaux et organisation des soins en psychiatrie	32				
12	Troubles de la sexualité	34				
13	Confusion mentale	36				
14	Troubles psychotiques brefs et transitoires	38				
15	Addictions	40				
16	Trouble du spectre de l'autisme (TSA)	44				
17	Déficiences intellectuelles	46				
18	Développement chez l'enfant et l'adolescent	48				
19	Adolescence et ses troubles	52				
20	Carence de soins maternels	54				

II. Travaux dirigés :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
21	Prescription et surveillance des psychotropes	58				
22	Prise en charge de l'agitation psychomotrice	62				
23	Examen et prise en charge de l'insomnie	64				
24	Prise en charge devant un état suicidaire	66				
25	Généralités sur les thérapeutiques en psychiatrie	68				
26	Dépistage du TSA	70				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Cours

© 2026 The WIZ. Tous droits réservés.

URGENCES PSYCHIATRIQUES (1)

I. DÉFINITION ET OBJECTIFS

- Urgence psychiatrique : trouble mental aigu exposant le patient ou autrui à un danger imminent ou une souffrance aiguë
- Objectifs : sécurité du patient/entourage, évaluation des risques (suicide, hétéro-agressivité), soulagement de la crise, orientation adaptée

II. PRINCIPES ÉTHIQUES ET LÉGAUX

- Respect du consentement et de la dignité
- Application du Code de la santé publique
- Traçabilité rigoureuse (certificats, dossiers)

III. GRANDES CATÉGORIES D'URGENCES

Type	Risque	Exemple
Suicidaire	Auto-agression, décès	TS, idées suicidaires structurées
Agitation aiguë	Hétéro-agressivité	Épisode maniaque, délirant, intoxication
Délirante/hallucinoire	Passage à l'acte	Bouffée délirante aiguë
Dépressive	Suicide, arrêt de soins	Épisode dépressif majeur
Anxieuse	Panique, fuite	Attaque de panique massive
Médico-psychiatrique	Cause organique	Encéphalopathie, sevrage, intoxication
Détresse sociale	Rupture de soins	SDF, isolement

IV. ÉVALUATION CLINIQUE

- Recueil : motif, contexte, antécédents psychiatriques/somatiques, traitements, substances
- Examen psychiatrique :
 - Conscience, orientation, comportement
 - Discours (cohérence, contenu délirant, idées suicidaires)
 - Affectivité (anxiété, dépression, colère)
 - Insight/jugement
- Examen somatique systématique :
 - Constantes vitales (TA, FC, FR, T°, SpO₂)
 - Bilan : glycémie, ionogramme, fonction rénale, toxiques urinaires, ECG
 - Vigilance particulière : sujet âgé, apparition tardive, symptomatologie atypique, mauvaise réponse au traitement

V. PRISES EN CHARGE SPÉCIFIQUES

1. Urgence suicidaire (30-50% des cas)

- Évaluer : idées de mort, moyens, accessibilité, isolement, antécédents
- Conduite : ne pas minimiser, supprimer l'accès aux moyens létaux, surveillance rapprochée, hospitalisation si risque élevé

2. Agitation et violence

- Causes : maniaque, schizophrénie, délire, hypoglycémie, TC, sevrage, toxiques
- Conduite : sécuriser l'environnement, approche verbale calme, contention (dernier recours), sédation (benzodiazépines ou antipsychotiques IM)

3. Bouffée délirante aiguë

- Début brutal, délire polymorphe (mystique, persécutif...)
- Hospitalisation systématique (souvent sous contrainte)
- Antipsychotique atypique (rispéridone, olanzapine, aripiprazole)

4. Urgence dépressive

- Idées suicidaires, culpabilité, agitation, refus alimentaire
- Surveillance continue, hospitalisation si dangerosité, ISRS/IRSNa

5. Urgence anxieuse/panique

- Éliminer cause somatique (embolie, hypoglycémie, infarctus)
- Rassurer, benzodiazépine courte durée, orientation TCC

6. Urgences médico-psychiatriques

- Intoxications, sevrage, troubles confusionnels
- Hospitalisation en milieu somatique, correction de la cause organique d'abord

URGENCES PSYCHIATRIQUES (2)

VI. STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

- Traitement symptomatique d'abord
- Tenir compte des traitements en cours
- Information du patient/famille (alliance thérapeutique)
- Sédation médicamenteuse si nécessaire
- Traitement étiologique

VII. ORIENTATION

- Unité d'hospitalisation psychiatrique
- Service de médecine/réanimation
- Ambulatoire avec suivi rapproché

VIII. COMPLICATIONS ET RISQUES MÉDICO-LÉGAUX

- Suicides/homicides après évaluation insuffisante
- Contentions non justifiées ou non tracées
- Erreurs médicamenteuses
- Défaut de coordination
- Négligence de cause organique

IX. CONTENTION PHYSIQUE (DERNIER RECOURS)

- Échec du traitement médical
- Risque auto/hétéro-agressif ou de fugue
- Prescription médicale, personnel qualifié (≥ 4 personnes), matériel homologué
- Surveillance régulière, réévaluation, prévention des complications

X. CONCLUSION

- Fréquentes, complexes, potentiellement vitales
- Évaluation clinique rapide et sécurisée
- Collaboration multidisciplinaire essentielle

MOTS-CLÉS :
SÉCURITÉ ET HUMANITÉ